

E

悪性リンパ腫、白血病
malignant lymphoma, leukemia

1

原発性および続発性胸部悪性リンパ腫
primary and secondary chest malignant lymphoma

到達目標

- 悪性リンパ腫の WHO 分類の概要を説明できる
- 胸郭内において最も頻度の高い MALT リンパ腫の診断・治療を説明できる
- 胸郭内のその他の悪性リンパ腫の診断・治療を説明できる

呼吸器関連の悪性リンパ腫

呼吸器関連の悪性リンパ腫には、肺・縦隔など胸腔内から発生する原発性のものと、他臓器原発で胸腔内に病変を形成する続発性のものがある。肺原発の悪性リンパ腫は肺悪性腫瘍の 0.5% 未満、全リンパ腫の 1% 未満、節外性 non-Hodgkin リンパ腫の 3~4% と比較的まれである^{1,2)}。呼吸器関連のリンパ腫にかかわる病理分類には、胸部腫瘍の WHO 分類³⁾と、血液・リンパ系腫瘍の WHO 分類⁴⁾の 2 つが存在する。後者のうち、原発性悪性リンパ腫の WHO 分類では、成熟 B 細胞腫瘍、成熟 T 細胞および NK 細胞腫瘍、リンパ組織の間質由来腫瘍などに分類されている⁴⁾が、MALT リンパ腫を主体とした B 細胞腫瘍が呼吸器関連リンパ腫の大多数を占めている。悪性リンパ腫の病期診断や治療効果判定には、PET (FDG-PET) - CT が多く実施される⁵⁾。

ここでは原発性胸部悪性リンパ腫の代表例（表 1）とともに、続発性悪性リンパ腫についても概説する。

1

粘膜関連リンパ組織型節外性辺縁帯リンパ腫（MALT リンパ腫）

病因・病態・疫学

他臓器のリンパ腫では、中悪性度のびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫の頻度が高いのに対し、肺では低悪性度リンパ腫が 80% 以上を占め、その中の大部分が MALT リンパ腫（mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma）である⁶⁾。一般的に MALT リンパ腫は、胃や唾液腺、甲状腺などに慢性炎症を背景として発症しやすく、臨床背景として *Helicobacter pylori* 感染や Sjögren 症候群、橋本病などの自己免疫性疾患が有名である。肺における MALT リンパ腫は 50~70 歳代に好発し、やや男性に多い。

症候・身体所見

経過は緩徐であり、多くの症例（50~88%）が無症状で健診などの胸部異常影として発見される。有症状でも咳嗽や呼吸困難、胸痛など非特異的な症状が多い⁶⁾。

診断・検査

血清 LDH・可溶性 IL-2 レセプター（sIL-2R）の上昇は通常みられない。胸部 CT では結節影・腫瘤影や浸潤影が最も多く、気管支血管周囲に好発する。造影 CT における CT angiogram sign も診断に役立つ。肺門縦隔リンパ節腫大は約 30% に認められる。組織学的には胚中心細胞類似（centrocyte-like : CCL）細胞、単球様 B 細胞、小型リンパ球、および少数の免疫芽球や胚中心芽球など多彩な B 細胞から構成される節外性 B 細胞性リンパ腫である。「濾胞性リンパ

表 1 主な原発性胸部悪性リンパ腫の分類

成熟 B 細胞腫瘍
1. 粘膜関連リンパ組織型節外性辺縁帯リンパ腫（MALT リンパ腫）：Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue
2. びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫・非特定型：Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), NOS*
3. 前縦隔（胸腺）原発大細胞型 B 細胞リンパ腫：Primary mediastinal (thymic) large B cell lymphoma (PMBL)
4. リンパ腫様肉芽腫症：Lymphomatoid granulomatosis (LYG)
5. 原発性体腔液リンパ腫：Primary effusion lymphoma (PEL)
6. 慢性炎症関連のびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫 嚢胸関連リンパ腫：Pyothorax-associated lymphoma (PAL)
7. 血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫：Intravascular large B-cell lymphoma
免疫不全・免疫調節異常に関連したリンパ増殖症およびリンパ腫
医原性・治療関連の免疫不全・免疫調節異常に関連したリンパ増殖症およびリンパ腫（Methotrexate や他の免疫抑制薬関連を含む）

*NOS : not otherwise specified